

尿动力学检查

WARWIKI

患者须知 · 评估膀胱充盈与排空功能的检查

尿动力学检查（urodynamics）是一组检测膀胱储尿和排尿功能的测试。检查时，细软的导尿管（catheter）会向膀胱缓慢注水并同步测量压力。目的是在诊室内重现您的症状，帮助医疗团队找出病因并制定合适的治疗方案。

关于这项检查

尿动力学检查并非单一测试，而是多项检查的组合。根据您的情况，可能包括：

- **尿流率测定** — 您在专用马桶上排尿，仪器记录尿流速度和形态，团队随后检查残余尿量。
- **充盈期膀胱测压** — 向膀胱缓慢注水，同时测量压力并记录您的感受。
- **压力-流率测定** — 排尿时同步测量膀胱压力。
- 有时会同步拍摄**X光影像**（影像尿动力学）。

检查使用两根细管：一根经尿道置入膀胱，另一根极细的管置入直肠（或阴道），用于测量腹压，从而区分膀胱压力与腹部用力的影响。

安全吗？

安全。尿动力学检查风险极低，属于互动式测试。主要风险来自导尿管——短暂的轻微灼热感和较小的尿路感染（UTI）概率。医生可能会给您预防性抗生素。无需手术，也无需恢复期。

名词解释

尿动力学检查

一组评估膀胱储尿与排尿功能的测试。

膀胱

储存尿液直至排尿的肌性囊袋。

导尿管

用于向膀胱注水并测量压力的细软管。

充盈期膀胱测压

膀胱缓慢充盈时测量压力与感觉变化。

压力-流率测定

排尿时测量膀胱压力，评估排空功能。

尿流率测定

测量尿流速度与形态。

影像尿动力学

同步结合X光影像的尿动力学检查。

残余尿量

排尿后膀胱内剩余的尿液量。

会疼吗？ 大多数人感受到的是导尿管带来的压迫感和轻微不适，而非真正的疼痛。检查中您会被要求咳嗽、变换体位并排尿——医疗团队会为您遮盖并按您的节奏进行。检查通常约30–60分钟，完成后即可离开。

如何准备（检查前）

- 您可能需要**憋尿至适度充盈**后到达——请遵照预约时收到的具体说明。
- 照常服用**日常药物**，但请询问是否需要**暂停膀胱相关药物**，因为它们可能影响检查结果。
- 检查无需镇静，通常可以**自行驾车回家**。

如有以下情况，请**提前告知医疗团队**：

- 有**尿路感染**迹象（排尿灼热、发热，或尿液浑浊、气味异常）——活动性感染可能需要改期
- 正在服用抗凝药，或有任何过敏史（包括乳胶过敏）

检查前您可能需要提供**尿液样本**以排除感染。

过程

- 您先在专用马桶上排尿，仪器记录尿流并检测残余尿量。
- 轻柔置入细导尿管——一根进入膀胱，另一根细管置入直肠或阴道。
- 膀胱缓慢注水，您需报告初次有感觉的时刻及强烈尿意出现的时刻；期间可能被要求咳嗽或变换体位。
- 在压力持续记录的同时排尿，随后取出导尿管。

之后

- 可**立即恢复正常活动**。
- 排尿时可能有**轻微灼热感**，持续一两天。多喝水有助于缓解。
- 尿液可能出现**淡粉色**，属正常现象，通常一天内消退。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热或寒战
- 排尿困难或完全无法排尿
- 大量出血或尿液中出现血块
- 疼痛持续加重

需要记住的三件事

- 尿动力学检查评估膀胱充盈与排空功能，帮助医疗团队找出漏尿、尿急或排空困难的原因并制定治疗方案。
- 准备工作很简单：询问是否需要暂停膀胱药物，按要求憋尿至适度充盈后到达，并提前告知有无感染迹象。
- 检查以压迫感为主而非疼痛，结束后即可回家。轻微灼热感或尿液淡粉色持续一天属正常——多喝水；若出现发热、大量出血或排尿困难请及时就医。